

Эту статью можно читать бесплатно.

Лучшие и худшие привычки для вашей печени

Заболевания печени становятся все более распространенными во всем мире. Ваш рацион, режим тренировок и другие факторы могут повлиять на риск развития этих заболеваний.



Прослушать · 6:19 мин



Автор Нина Агравал

Опубликовано 23 июля 2026 г. Обновлено 25 июля 2026 г.

Смотрите больше наших материалов в результатах поиска.

Добавьте The New York Times в Google ↗

Печень — мощный орган: она фильтрует нашу кровь, помогает поддерживать уровень сахара, накапливает энергию и играет важную роль в пищеварении.

Неправильное питание, недостаток физической активности и другие заболевания могут привести к болезням печени и раку печени, число которых растет во всем мире.

Часто можно предотвратить заболевание печени или даже обратить его вспять, изменив только свой рацион и образ жизни. Вот что может помочь, а также какие привычки могут причинять вред.

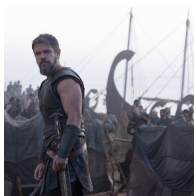
Худшие привычки

Злоупотребление алкоголем.

Регулярное употребление алкоголя, метаболическая дисфункция или их сочетание могут привести к так называемой стеатогепатиту. Жир накапливается в печени и может привести к воспалению, рубцеванию и циррозу, говорит доктор Зобаир Юноси, председатель Глобального центра исследований результатов лечения заболеваний печени и политики в области здравоохранения при Медицинской школе Джорджтаунского университета.

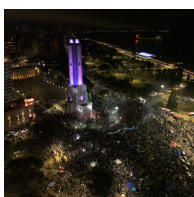
По словам доктора Юноси, у людей с нарушениями обмена веществ, такими как диабет 2-го типа, высокое кровяное давление или избыток абдоминального жира, умеренное употребление алкоголя может усугубить повреждение печени. Злоупотребление алкоголем (употребление пяти и более порций за один раз) наиболее опасно.

Еще можно читать бесплатно



«Одиссея» арендовала корабль викингов. Говорят, он вернулся поврежденным.

3 МИНУТЫ ЧТЕНИЯ



Аргентинцам есть что сказать в ответ на шквал критики

5 МИНУТ ЧТЕНИЯ

Людям с прогрессирующим заболеванием печени врачи рекомендуют полностью отказаться от алкоголя. Но при менее выраженных заболеваниях или их отсутствии допустимо употребление до одной порции алкоголя в день, хотя лучше вообще не пить, считает доктор Мэри Ринелла, директор отделения метаболических и жировых заболеваний печени в Чикагском университете.

Перебор с сахаром.

Сахар является строительным материалом для образования жира в печени. По словам доктора Ринеллы, при его избытке «механизм дает сбой» и клетки печени испытывают стресс. Инсулинорезистентность, которая может возникнуть при хроническом злоупотреблении сахаром, также способствует накоплению жира в печени.

Существует множество доказательств связи высокого потребления сахара, особенно в составе сладких напитков, с метаболической дисфункцией, ассоциированной со стеатозом печени, или МДАСП, говорит Шира Зельбер-Саги, клинический диетолог и эпидемиолог из Хайфского университета в Израиле.

Добавленные сахара, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который содержится во многих продуктах глубокой переработки и газированных напитках, особенно вредны для печени. Согласно

рекомендациям, женщинам следует употреблять не более 25 граммов, а мужчинам — не более 36 граммов добавленного сахара в день.

Доктор Зельбер-Саги говорит пациентам, что иногда можно позволить себе кусочек торта, но ни в коем случае нельзя пить подслащенные сахаром напитки. «Это формирует очень сильную зависимость, а она нам не нужна», — говорит она.

Relying on supplements.

Dawn Anderson, a clinical dietitian at Virginia Commonwealth University, said patients often ask her about liver cleanses, detoxes and supplements like milk thistle and mushroom coffee. There is little evidence that these unregulated products have any liver benefits, experts said. “Your liver is already your body’s detoxification system. It does not need a cleanse,” Ms. Anderson said. And these products may cause harm if they contain unknown ingredients or excessive quantities of certain ingredients.

The Best Habits

Exercising and maintaining a healthy weight.

Losing weight can help reduce fat buildup, inflammation and scarring in the liver. Just a 3-percent reduction in body weight can improve liver health markers, but 10 percent or more is needed to reverse scarring.

GLP-1 drugs like Wegovy, which are approved to treat an advanced type of MASLD, have been “a game-changer,” Dr. Zelber-Sagi said. But they must be used in conjunction with exercise, particularly strength training, because muscle loss can worsen outcomes in people with MASLD.

Engaging in at least 150 minutes of aerobic activity, and strength training twice a week, helps reduce abdominal fat and insulin resistance, Dr. Zelber-Sagi said.

Aiming for a Mediterranean-style diet.

The Mediterranean diet, which centers on fresh fruits, vegetables, fish and legumes and is rich in healthy fats, has been shown to reduce the risk of cardiovascular disease, a leading cause of death in people with nonalcoholic liver disease. It is low in saturated fats, which are found in red meat, dairy and palm oil and can increase fat in the liver.

But it’s not always practical to stick strictly to the diet, experts acknowledged. Ms. Anderson said that while many of her patients follow a traditional Southern diet, they can incorporate Mediterranean elements. “We can have collard greens, cabbage, maybe a summer squash, a cucumber and onion salad,” she said.

For protein she suggests adding fish or white meat and cutting back on fatty cuts of red meat. She also encourages people to grill, rather than fry, and to use butter only for flavoring.

Lastly, coffee (up to four cups a day) has been shown in animal studies to reduce fat and scar formation in the liver, and is associated in humans with a lower risk of cirrhosis, Dr. Rinella said.

Staying up-to-date on primary care.

Hepatitis B and hepatitis C are significant drivers of liver disease worldwide. The Centers for Disease Control and Prevention recommend that all adults be screened at least once for hepatitis B and hepatitis C. Both can be treated. Adults should also be vaccinated against hepatitis B if they weren't as babies, Dr. Rinella said.

Primary care doctors can do these screenings. They can also estimate your liver disease risk with the help of routine lab results. If you have Type 2 diabetes, you should talk to your doctor about getting liver stiffness testing, which can show progressing liver disease.

Corrected on July 25, 2026: An earlier version of this story misspelled the given name of a liver health expert. The expert is Dr. Zobair Younossi, not Zoubair.

We acknowledge mistakes in our reporting with corrections. If you spot an error, please let us know at corrections@nytimes.com. [Learn more.](#)

Nina Agrawal is a Times health reporter.